FICHE CONTENTION

Prescription, surveillance et réévaluation d'une contention physique

Mesure d'exception : en dernier recours, après échec des alternatives, proportionnée au danger, la plus courte possible, réévaluée et tracée.

RÉSIDENT : Nom ..... Prénom ..... Né(e) le .....

Établissement / unité ..... **Date de mise en place** ..... **Heure** .....

DANGER IDENTIFIÉ (motif de la contention) :

- ☐ Mise en danger de soi (risque de blessure grave)
- ☐ Danger pour autrui
- ☐ Protection d'un dispositif médical (sonde, perfusion…)
- ☐ Autre : .....

Description précise du danger et des circonstances :

Attention : un risque de chute, une déambulation ou une agitation ne justifient pas à eux seuls une contention (ANAES 2000, HAS 2005).

1. VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Alternatives tentées (au moins une, à tracer) :

- ☐ Cause recherchée et traitée (douleur, globe, fécalome, infection, trouble glycémique, iatrogénie…)
- ☐ Traitements revus
- ☐ Lit bas ou très bas, sans barrières
- ☐ Éclairage renforcé
- ☐ Espace de déambulation sécurisé
- ☐ Activités, promenades accompagnées
- ☐ Écoute, présence des proches sollicitée
- ☐ Accompagnement programmé aux toilettes
- ☐ Autre : .....

Évaluation et information :

- ☐ Examen médical le .....
- ☐ Décision prise en équipe pluriprofessionnelle

Avis du résident recherché :
☐ accord ☐ refus ☐ non exprimable

- ☐ Information de la personne de confiance / famille, le ..... par .....
- ☐ Mesure de protection avec représentation relative à la personne : représentant informé / accord recueilli
- ☐ EHPAD : annexe au contrat de séjour établie / mise à jour (CASF R311-0-5 à R311-0-9)
- ☐ Environnement sécurisé (sonnette à portée, obstacles retirés, chaussage adapté)

Risques de la contention, à prévenir :

chute avec le dispositif, compression ou strangulation (harnais, barrières, sangles), escarres, perte de mobilité et d'autonomie, confusion, agitation accrue, souffrance psychique (ANAES 2000).

2. DISPOSITIF ET PRESCRIPTION

Contention restrictive :

- ☐ Ceinture pelvienne / abdominale
- ☐ Harnais / gilet ☐ Bloque-ceinture
- ☐ Barrières de lit ☐ Combinaison / body
- ☐ Sangle : .....

Maintien postural (aide à l'installation) :

- ☐ Fauteuil confort / coquille ☐ Plastron
- ☐ Verticalisateur ☐ Autre : .....
- ☐ Matériel adapté à la morphologie, taille vérifiée, installé selon la notice du fabricant

Lieu :
☐ Lit ☐ Fauteuil ☐ Chambre ☐ Autre : .....

Période :
☐ Jour ☐ Nuit ☐ Continu de ..... à .....

Validité de la prescription médicale :

- ☐ **24 heures, renouvelable après réévaluation** (contention restrictive : ANAES 2000)
- ☐ Maintien postural : jusqu'au .....

Précisions du prescripteur :

Sources : ANAES 2000, limiter les risques de la contention physique de la personne âgée · HAS 2005 · ANESM 2016, comportements-problèmes (volets 1-2) · Consensus 2004, liberté d'aller et venir · CASF L311-4-1 et R311-0-5 à R311-0-9 (annexe au contrat de séjour, EHPAD) · ANSM 2020, dispositifs de contention. Fiche DOTR, V1, octobre 2026.

FICHE CONTENTION (suite)

Résident : ..... Mise en place le : .....

3. SURVEILLANCE

Surveillance programmée et retranscrite (recommandation ANAES 2000)

Contrôle au moins toutes les ..... h · Levée et mobilisation au moins toutes les ..... h (hors sommeil)

Repères : contrôle au moins horaire, levée aussi souvent que possible, au moins toutes les 2 h selon certains auteurs (ANAES 2000).

Éléments à surveiller :

- ☐ Confort / tolérance
- ☐ Douleur
- ☐ Comportement / agitation
- ☐ État cutané, points d'appui
- ☐ Hydratation / alimentation
- ☐ Signes vitaux si besoin
- ☐ Position et sécurité du dispositif
- ☐ Élimination
- ☐ Autonomie, mobilité

Date	Heure	Observation (tolérance, peau, comportement…)	Levée	Nom / signature
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	

Grille à poursuivre dans le dossier du résident si besoin. Tout événement indésirable (chute, lésion, malaise) est signalé au médecin.

4. RÉÉVALUATION

Au moins à chaque renouvellement de la prescription ; mesure levée dès que le danger disparaît.

À chaque réévaluation : ☐ Pertinence (le danger persiste-t-il ?) ☐ Tolérance ☐ Nouvelles alternatives

Date de la prochaine réévaluation : ..... **ou lors de :** ☐ Synthèse pluridisciplinaire ☐ Changement clinique

Décision : ☐ Maintien ☐ Levée ☐ Adaptation du dispositif : .....

Mesures durables (maintien postural) — réévaluations effectuées (date) :

☐ Janv. ..... ☐ Févr. ..... ☐ Mars ..... ☐ Avril ..... ☐ Mai ..... ☐ Juin .....

☐ Juil. ..... ☐ Août ..... ☐ Sept. ..... ☐ Oct. ..... ☐ Nov. ..... ☐ Déc. .....

5. SIGNATURES

Professionnel référent (mise en place)

Nom / fonction .....

Date .....

Signature .....

Médecin prescripteur

Nom / fonction .....

Date .....

Signature .....

Direction (information)

Nom / fonction .....

Date .....

Signature .....

RAPPEL : la contention est une mesure de dernier recours, proportionnée, temporaire et réévaluée.

Prescription médicale motivée · traçabilité · respect des droits et de la dignité · information du résident et de ses proches.

Sources : ANAES 2000, limiter les risques de la contention physique de la personne âgée · HAS 2005 · ANESM 2016, comportements-problèmes (volets 1-2) · Consensus 2004, liberté d'aller et venir · CASF L311-4-1 et R311-0-5 à R311-0-9 (annexe au contrat de séjour, EHPAD) · ANSM 2020, dispositifs de contention. Fiche DOTR, V1, octobre 2026.